폐쇄성 수면무호흡증, 단순 코골이가 아닙니다

밤마다 반복되는 기도 막힘이 심장·뇌·혈관을 공격합니다 — 진단부터 치료까지 알아봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

10명 중 8명은 자신이 환자인 줄 모릅니다

폐쇄성 수면무호흡증의 약 80%는 진단받지 못한 채 지나갑니다

80%

진단받지 못함

단순 코골이로 여겨 지나치기 쉽습니다

3배

치료 안 한 중증 — 사망률

18년 추적 연구에서 모든 원인 사망

5.2배

치료 안 한 중증 — 심혈관 사망

같은 연구의 심장·혈관 원인 사망

코골이로 끝나지 않습니다

방치하면 고혈압·심방세동·뇌졸중·치매·당뇨병의 강력한 위험 요인이 됩니다.

진단과 치료는 잘 정립돼 있습니다

간단한 자가 문진(STOP-BANG)과 수면다원검사로 정확히 진단하고, 양압기 등 효과적인 치료가 있습니다.

Tip · 가족이 "자다가 숨을 멈춘다"고 말한다면 검사를 받아 보세요.

근거 · 위스콘신 수면 코호트 18년 추적 · 미국수면의학회(AASM) 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

폐쇄성 수면무호흡증이란

자는 동안 목 안 숨길이 좁아지거나 막혀 숨이 반복해서 멈추는 만성 질환입니다

숨길이 막힙니다

잘 때 목 근육이 풀리고 지방·뼈 구조가 숨길을 누르면 숨이 **10초 넘게 멈추거나** (무호흡), 줄어들며 산소가 **3% 넘게 떨어집니다**(저호흡).

밤새 깨어납니다

몸은 산소 부족을 느낄 때마다 뇌를 깨워 숨을 쉬게 합니다. 본인은 잤다고 느끼지만 뇌는 밤새 수십~수백 번 깼다 잠듭니다.

쌓이는 부담

깊은 잠이 사라지고, 산소 부족과 긴장 신경의 과한 흥분이 매일 밤 쌓입니다.

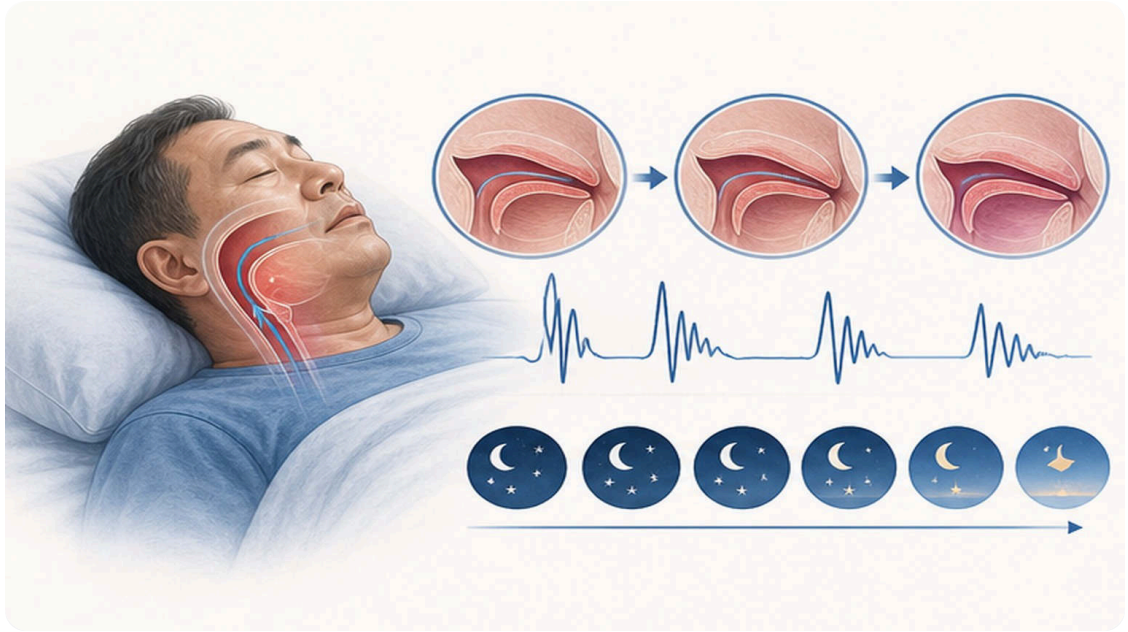


그림 · 잠든 사이 목 안 숨길이 좁아지다 막히며 호흡이 끊깁니다(설명용 그림).

Tip · 무호흡 10초, 산소 3% 저하가 한 번의 '사건'으로 셉니다.

근거 · 미국수면의학회(AASM) 수면 판독 매뉴얼 v2.6

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

중증도는 시간당 숨 멈춤 횟수로 나눕니다

무호흡-저호흡 지수(AHI) — 잠자는 1시간 동안 숨이 멈추거나 줄어든 횟수입니다

시간당 횟수	의미와 치료
5회 미만 · 정상	따로 치료 없이 지켜봅니다. 코골이·낮 졸음이 심하면 다른 수면장애를 확인합니다.
5~15회 · 경증	생활습관 교정이 먼저 — 체중 감량·옆으로 자기·금주·수면 위생. 증상·동반 질환이 있으면 양압기도 고려합니다.
15~30회 · 중등증	양압기 치료를 적극 권합니다. 건강보험 적용 대상이며 생활습관 교정과 함께하면 효과가 커집니다.
30회 이상 · 중증	바로 적극 치료합니다. 심장·뇌혈관 사건 위험이 가장 커서 양압기를 곧바로 시작하는 것이 표준입니다.

Tip · 치료 안 한 중증은 18년 추적에서 사망률 3배 — 진단되면 미루지 마세요.

근거 · 미국수면의학회(AASM) 중증도 분류 · 국제수면장애분류 3판

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

STOP-BANG — 3개 이상이면 정밀 검사

가장 널리 쓰는 8문항 선별 문진입니다 — 해당하면 1점, 민감도 89~95%

S · 큰 코골이

옆방에 들릴 만큼, 가족이 시끄럽다고 할 만큼 곱니다.

T · 낮에 피곤함

충분히 자도 개운하지 않고 운전·회의 중 졸립니다.

O · 숨 멈춤 목격

자다가 숨이 멎거나 컥컥거리는 모습을 가족이 봤습니다.

P · 고혈압

혈압약을 먹거나 조절이 안 돼 약을 늘리는 중입니다.

B · 체질량지수 35 초과

한국인은 30 이상부터 위험 — 몸무게(kg) ÷ 키(m)².

A · 50세 이상

나이가 들면 목 근육이 늘어져 위험이 커집니다.

N · 목둘레 40 cm 이상

목 주변 지방이 많으면 누웠을 때 숨길이 눌립니다.

G · 남성

남성이 약 2~3배 많습니다. 폐경 뒤 여성도 위험이 커집니다.

Tip · 3개 이상이면 수면다원검사를 상의해 보세요.

근거 · Chung 등, STOP-BANG 문진, BJA 2008

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

방치하면 어떤 병이 따라오나요

매일 밤 반복되는 산소 부족과 긴장 신경의 흥분이 온몸을 공격합니다



그림 · 수면무호흡은 심장·혈관·뇌·혈당까지 온몸에 영향을 줍니다 (설명용 그림).

1. **고혈압** 심장
   밤·새벽 혈압이 안 떨어지는 형태가 흔하고, 약을 더해도 안 잡히는 고혈압의 주요 원인입니다.
2. **심방세동 · 심부전** 심장
   중증이면 심방세동 위험이 약 4배, 심부전 환자의 30~50%에 동반됩니다.
3. **뇌졸중** 뇌
   중증은 뇌경색 위험을 약 2~3배 높입니다.
4. **2형 당뇨병** 대사
   산소 부족이 인슐린 저항성을 키워 당뇨 위험을 1.5~2배 높입니다.
5. **치매 · 인지 저하** 뇌
   깊은 잠에 뇌 노폐물을 치우는 기능이 무너져, 메타분석에서 치매 위험 26% 증가.
6. **낮 졸음 · 사고** 생활
   집중력 저하·우울감이 흔하고 졸음운전 사고 위험이 2~3배입니다.

Tip · 혈압약을 늘려도 안 잡히면 수면무호흡을 꼭 확인해 보세요.

근거 · 미국심장협회·심장학회 과학 성명 2021 · 수면무호흡과 심혈관·인지 위험

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

정확한 진단 — 수면다원검사

자가 문진에서 의심되면 병원에서 하룻밤 자며 숨 멈춤 횟수와 산소를 잽니다

항목	내용
어디서	병원 검사실에서 하룻밤(약 7시간) — 평소처럼 자면 됩니다
무엇을	뇌파·심전도·호흡·산소포화도·근육·다리 움직임
결과	시간당 숨 멈춤 횟수, 가장 낮은 산소, 산소가 부족했던 시간, 코골이, 잠의 단계
진단	시간당 5회 이상 + 증상 · 증상이 없어도 15회 이상
비용	2018년부터 건강보험 적용(조건 충족 시)



그림 · 여러 센서를 붙이고 하룻밤 자는 동안 호흡과 산소를 기록합니다(설명용 그림).

Tip · 수면다원검사는 수면무호흡 진단의 표준 검사입니다.

근거 · 국제수면장애분류 3판 진단 기준 · 건강보험심사평가원 급여 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

양압기 — 중등증 이상의 표준 치료

마스크로 일정한 압력의 공기를 불어 넣어 숨길을 열어 주는 수술 없는 1차 치료입니다

01

작동 원리

일정한 압력의 공기가 잠자는 동안 목 안 숨길이 무너지지 않게 **공기 부목**처럼 받쳐 줍니다.

숨길 받침

02

확인된 효과

낮 졸음·코골이가 줄고, 밤 산소·혈압·인지·삶의 질이 좋아집니다.

강력 권고

03

하루 4시간 이상

매일 4시간 이상 써야 효과를 기대합니다 — 심혈관 예방 효과는 아직 미확정입니다.

안경처럼 써야 효과

04

건강보험 유지 기준

처방 90일 안에, 연속 한 달 중 21일 이상·하루 4시간 이상 쓰면 급여가 유지됩니다.

첫 한 달이 관건

주의 대규모 연구(SAVE, 평균 하룻밤 3.3시간 사용)에서는 심혈관 예방 효과가 입증되지 않았습니다 — 가끔 쓰는 양압기는 충분하지 않습니다.

Tip · 첫 한 달 마스크 맞추기가 성공의 열쇠입니다 — 불편하면 참지 말고 알려 주세요.

근거 · 미국수면의학회(AASM) 양압기 지침 2019 · SAVE 연구 · RICCADSA 사후 분석

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

양압기가 어려워도 다른 길이 있습니다

플랜 A 가 어렵다면 플랜 B·C — 단계별 대안이 준비돼 있습니다

플랜 A — 양압기

· 중등증·중증의 1차 표준 치료 · 매일 밤 4시간 이상
· 낮 졸음·혈압·인지 기능이 빠르게 좋아짐
· 심혈관 효과는 4시간 이상 쓴 분에서 관찰됐지만 아직 확정되지 않음
· 건강보험 적용(조건 충족 시)

플랜 B·C — 다른 치료

· 아래턱을 앞으로 빼는 맞춤 치과 장치
· 옆으로 자기(자세 치료) — 자세 영향형에서 횟수 53.6% 감소
· 체중 감량 약 — 비만형에서 횟수 56% 감소
· 혀 신경 자극 장치(이식형) — 미국 기준(FDA, 2023) 체질량지수 40 이하
· 위아래 턱 전진 수술 85~87% 성공 · 목젖·입천장 수술만은 33~50%



그림 · 양압기 말고도 체중 관리·자세·치과 장치·수술 같은 길이 있습니다(설명용 그림).

Tip · 어떤 대안이 맞는지는 중증도·얼굴 구조·체중을 보고 함께 정합니다.

근거 · 미국수면의학회(AASM) 대안 치료 지침 2021 · SURMOUNT-OSA, NEJM 2024 · 미국 식품의약국(FDA) 승인 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 신호가 있으면 진료를 미루지 마세요

중증일 수 있는 단서입니다 — 하나라도 해당하면 바로 병원에 오세요

⚠ 운전·회의 중 졸음

신호 대기 중 깜빡 졸거나 차로를 벗어난 적이 있다면 본인과 다른 사람의 생명이 걸린 문제입니다. 운전을 멈추고 검사받으세요.

? 숨 멈춤 목격 + 컥컥거리며 깸

가족이 "숨이 멈추는 것 같다"고 하거나 숨이 막혀 깬다면 중증일 수 있습니다. 수면다원검사를 미루지 마세요.

아침 두통 + 밤 산소 저하

아침 두통·메스꺼움·고혈압이 함께면 밤사이 산소 부족을 의심합니다. 산소가 80% 아래인 시간이 길수록 위험이 큽니다.

안 잡히는 고혈압 · 심방세동

약 3가지로도 혈압이 안 잡히거나 심방세동·심부전을 새로 진단받았다면 수면무호흡을 꼭 확인하세요.

Tip · 졸음운전 위험이 있으면 치료가 자리 잡을 때까지 운전을 삼가세요.

근거 · 미국수면의학회(AASM) 중증 위험 신호 · 대한가정의학회 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘부터 실천할 여덟 가지

체중·자세·금주만 잘 지켜도 숨 멈춤 횟수가 의미 있게 줄어듭니다

01 옆으로 누워 자기 — 자세 영향형에서 횟수 53.6% 감소

02 체중 10% 줄이기 — 치료 효과를 크게 끌어올립니다

03 잠자기 3시간 전부터 술 마시지 않기 — 술은 목 근육을 풀어 숨길을 좁힙니다

04 금연 — 흡연은 숨길에 염증·부기를 만듭니다

05 주말에도 같은 시간에 자고 일어나기

06 양압기를 처방받았다면 매일 밤 4시간 이상

07 수면제·안정제·근육이완제는 의사와 상의 후 사용

08 피곤할 때는 운전하지 않기 — 가족과 함께 지키기

Tip · 작은 습관부터 하나씩 — 가족에게 코골이 변화를 물어보세요.

근거 · 미국수면의학회(AASM) · 생활습관 교정과 치료 유지 지원

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

코골이·수면무호흡이 걱정되는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 검사와 치료 방법은 담당 의료진과 상의해 정합니다.

참고한 자료

미국수면의학회(AASM) 판독 매뉴얼·양압기·대안 치료 지침 · 위스콘신 수면 코호트 · SAVE·RICCADSA 연구 · STOP-BANG(BJA 2008) · 건강보험심사평가원

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요